

RESTORATİF, ENDODONTİK VE PERIODONTAL İŞLEMLER HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

Hasta Adı Soyadı:	T.C. Kimlik No:	Tarih: / / 20.... Saat: :
----------------------------	--------------------------	--

1. Teşhis / İşlem Planlanan Diş veya Bölge

Hekim; restoratif, endodontik veya periodontal işlem planlanan diş/bölgeleri şema üzerinde işaretler; teşhis ve klinik planı aşağıya yazar.

Üst Çene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
Alt Çene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Teşhis / klinik bulgular:	
Planlanan işlem:	Restoratif işlem / kanal tedavisi / periodontal işlem / diş taşı / diş eti şekillendirme / diğer:
Özel not:	Gerektiğinde ilgili diş için doktor görüşüyle kanal tedavisi ya da dolgu/kuafaj işlemi uygulanacaktır. Ek açıklama:

2. Lokal Anestezi Bilgilendirmesi ve Komplikasyonları

İşlem sırasında gerekli görülürse lokal anestezi uygulanabilir. Kliniğimizde lokal anestezi amacıyla lidokain ve/veya artikain etken maddeli, adrenalini veya adrenalinsiz anestetik solüsyonlar kullanılabilir. Lokal anestezi uygulanacak bölgede sinir iletimini geçici olarak azaltır veya durdurur; uyuşukluk kişiye, uygulama bölgesine ve kullanılan ilaca göre değişmekle birlikte yaklaşık 1-4 saat sürebilir. Lokal anestezi sonrası geçici uyuşukluk, dudak/yanak/dil ısırmasına bağlı travma, enjeksiyon bölgesinde ağrı, ödem, morarma, kas spazmı, çene açmada kısıtlılık, geçici kas zayıflığı, geçici yüz felci, geçici his kaybı, anestezinin yetersiz kalması veya tekrarlanması ihtiyacı görülebilir. Nadir olarak lokal anesteziklere veya içeriğindeki maddelere bağlı alerjik reaksiyon, kaşıntı, döküntü, anjiyödem, tansiyon değişikliği, çarpıntı, solunum güçlüğü ve anafilaksi/anafilaktik şok gelişebilir; bu durumda acil tıbbi müdahale gerekebilir.

3. RESTORATİF İŞLEMLER ☐

İşlemden beklenen faydalar: Çürük veya hasarlı dokunun uzaklaştırılması, diş dokusunun korunması, ağrı/hassasiyetin azaltılması, madde kayıpları ve estetik aralıkların giderilmesi, dişin form, fonksiyon ve estetiğinin iyileştirilmesi, dişin ağızda tutulmasına katkı sağlanması beklenir.

İşlem nasıl yapılır, nerede/kim tarafından yapılır ve tahmini süre: İşlem, hekimleri tarafından uygulanır. Gerekli görülürse lokal anestezi yapılır; çürük, zayıf veya eski restorasyon dokuları temizlenir, izolasyon sağlanır. Hekimin uygun gördüğü restoratif malzeme uygulanır, şekillendirilir; kontakt ve kapanış kontrolü yapılarak polisajlanır. Diastema kapatmada diş yüzeyi minimal pürüzlendirilebilir ve adeziv işlemlerle şekillendirme yapılabilir. Tahmini süre diş/bölge başına çoğunlukla 20-60 dakikadır; diş sayısı, çürük derinliği, kanama, izolasyon ve estetik gerekliliklere göre değişebilir.

Alternatifler: Takip, flor/desensitizan uygulamaları, farklı restoratif materyal, inley/onley/overlay, kuron, lamina, ortodontik tedavi, kanal tedavisi, kanal tedavisi yenileme, apikal cerrahi, diş çekimi ve çekim sonrası implant/köprü/hareketli protez seçenekleri değerlendirilebilir. Her seçenek her diş ve hasta için uygun olmayabilir.

Riskler ve komplikasyonlar: Kesin başarı, estetik memnuniyet, hassasiyetin tamamen geçmesi veya restorasyonun ömür boyu dayanması garanti edilemez. Geçici/kalıcı hassasiyet, ağrı, yüksek dolgu hissi, renk uyumsuzluğu, kenar sızıntısı, kontakt bozukluğu, gıda sıkışması, dolgu kırılması/düşmesi/aşınması, diş eti travması/kanaması, alerjik reaksiyon ve diş dokusunda çatlak/kırık görülebilir. Derin çürüklerde kuafaja rağmen ağrı gelişebilir, pulpa canlılığı korunamayabilir ve kanal tedavisi gerekebilir. Diastema kapatmada ayrılma, aşınma, renklenme, aralığın tekrar belirginleşmesi, kontur/konum uyumsuzluğu ve ek düzeltme ihtiyacı olabilir.

İşlem yapılmazsa ne olur: Çürük ve madde kaybı ilerleyebilir; sıcak-soğuk hassasiyeti, ağrı, pulpa iltihabı, apse, fistül, yüz şişliği, kök ucu lezyonu, diş kırığı, çigneme ve estetik sorunlar gelişebilir. Uygun zamanda tedavi edilmeyen dişlerde kanal tedavisi, cerrahi işlem veya çekim ihtiyacı olabilir.

İşlem öncesi/sonrası dikkat ve hastanın belirtmesi gereken durumlar: Hasta sistemik hastalıklarını, gebelik durumunu, kullandığı ilaçları, alerjilerini ve daha önce yaşadığı dental problemleri hekime bildirmelidir. Anestezi geçene kadar dudak/yanak/dil ısırmamaya dikkat etmeli; hekimin önerdiği süre boyunca sert, yapışkan ve renklendirici gıdalardan kaçınmalıdır. Yüksek dolgu hissi, geçmeyen ağrı, şişlik, kötü tat/koku, dolgu düşmesi/kırılması veya diastema restorasyonunda ayrılma olursa kliniğe bilgi vermelidir.

4. ENDODONTİK İŞLEMLER ☐

İşlemden beklenen faydalar: Enfekte, iltihaplı veya canlılığını kaybetmiş pulpa dokusunun temizlenmesi, ağrı ve enfeksiyonun azaltılması, kök kanallarının dezenfeksiyonu, dişin ağızda tutulması ve fonksiyonunun devam ettirilmesi beklenir.

İşlem nasıl yapılır, nerede/kim tarafından yapılır ve tahmini süre: İşlem, hekimleri tarafından uygulanır. Lokal anestezi gerekebilir. Dişin iç kısmına ulaşılır, kök kanalları bulunur, özel kanal aletleri ile temizlenir ve şekillendirilir. Kanalların dezenfeksiyonu için klinik gerekliliğe göre sodyum hipoklorit, EDTA, klorheksidin, serum fizyolojik/distile su ve hekimin uygun gördüğü diğer yıkama solüsyonları kullanılabilir. Tedavi tek veya çok seanslı olabilir; gerekirse kanal içine ilaç konulabilir. Kanal dolgusu sonrası kalıcı üst restorasyona tamamlanması gerekebilir. Her seans yaklaşık 30-90 dakika sürebilir; süre kanal sayısı, enfeksiyon, kanal anatomisi ve hasta uyumuna göre değişebilir.

Alternatifler: Takip, geçici medikal tedavi, kuafaj, dolgu, kanal tedavisi yenileme, apikal cerrahi, diş çekimi ve çekim sonrası implant, köprü veya hareketli protez seçenekleri değerlendirilebilir. Dişin prognozu; kök anatomisi, enfeksiyon büyüklüğü, çatlak/kırık varlığı, periodontal destek ve hastanın hijyenine göre değişebilir.

Riskler ve komplikasyonlar: Kesin başarı garantisi verilemez. Kanalin bulunamaması, kanalın tıkalı/eğri/kalsifiye olması, kanal aleti kırılması, basamak/perforasyon, kök çatlağı/kırığı, işlem sonrası çigneme ağrısı, enfeksiyonun devamı/tekrarı, kanal tedavisi yenileme, apikal cerrahi veya çekim ihtiyacı oluşabilir. Yıkama solüsyonu, kanal patı veya kanal dolgu materyalinin apekten taşması halinde ağrı, şişlik, yanma, kimyasal irritasyon, doku hasarı, iyileşmede gecikme, ek takip/tedavi veya cerrahi müdahale ihtiyacı görülebilir. Üst ön grup dişlerde nadiren renk değişikliği oluşabilir.

İşlem yapılmazsa ne olur: Ağrı artabilir, pulpa iltihabı veya enfeksiyon ilerleyebilir; apse, fistül, yüz şişliği, kök ucu lezyonu, kemik kaybı ve diş çekimi gerekebilir. Ağrının geçici azalması enfeksiyonun tamamen iyileştiği anlamına gelmeyebilir.

İşlem öncesi/sonrası dikkat ve hastanın belirtmesi gereken durumlar: Hasta sistemik hastalıklarını, alerjilerini, kullandığı ilaçları ve önceki tedavi/uyuşma sorunlarını hekime bildirmelidir. Seanslar arasında geçici dolgu düşerse, dişte kırık oluşursa veya ağrı/şişlik artarsa kliniğe başvurulmalıdır. Tedavi tamamlanmadan dişle sert çiğneme yapılmamalı; kanal tedavisi sonrası önerilen kalıcı üst restorasyon geciktirilmemelidir.

5. PERIODONTAL İŞLEMLER ☐

İşlemden beklenen faydalar: Diş taşı, plak ve iltihabi birikimlerin uzaklaştırılması; diş eti kanaması, ağız kokusu ve iltihabın azaltılması; diş eti sağlığının iyileştirilmesi; restoratif/protetik işlemler için daha uygun diş eti konturunun sağlanması ve dişlerin ağızda daha sağlıklı tutulmasına katkı sağlanması beklenir.

İşlem nasıl yapılır, nerede/kim tarafından yapılır ve tahmini süre: İşlem, hekimleri tarafından uygulanır. Diş taşı temizliği, kök yüzeyi temizliği ve diş eti şekillendirme işlemleri ultrasonik cihazlar, el aletleri, polisaj materyalleri ve hekimin uygun gördüğü yöntemlerle yapılabilir. Diş eti şekillendirmede uygun vakalarda lokal anestezi, bistüri, elektrokoter, lazer veya döner aletler kullanılabilir. Tahmini süre çoğunlukla 20-60 dakikadır; yaygın diş taşı, kanama, hassasiyet, cep derinliği ve işlem yapılacak bölge sayısına göre değişebilir.

Alternatifler: Hijyen eğitimi ve takip, profesyonel temizlik, lokal periodontal tedavi, küretaj/kök yüzeyi düzleştirme, cerrahi periodontal tedavi veya ileri periodontal değerlendirme planlanabilir. Diş eti şekillendirmeye alternatif olarak takip, restoratif/protetik plan değişikliği veya ileri periodontal/cerrahi tedavi değerlendirilebilir.

Riskler ve komplikasyonlar: İşlem sonrası geçici kanama, hassasiyet, sızlama, diş eti çekilmesinin daha belirgin hale gelmesi, dişler arasında açıklıkların fark edilmesi, geçici sallanma hissi, yara, şişlik, ağrı, renk/doku değişikliği, estetik beklentinin tam karşılanmaması, ek seans veya ek tedavi ihtiyacı oluşabilir. Diş eti şekillendirme sonrası iyileşme süreci kişiye göre değişir; tekrar şekillendirme gerekebilir.

İşlem yapılmazsa ne olur: Diş taşı/diş eti problemleri tedavi edilmezse kanama, ağız kokusu, diş eti çekilmesi, cep derinliği artışı, kemik kaybı, dişlerde sallanma, estetik ve fonksiyon sorunları ilerleyebilir. Restoratif veya protetik tedavilerde uyum, estetik ve uzun dönem başarı olumsuz etkilenebilir.

İşlem öncesi/sonrası dikkat ve hastanın belirtmesi gereken durumlar: Hasta kanama bozukluğu/kan sulandırıcı kullanımı, gebelik durumu, alerjileri ve kullandığı ilaçları hekime bildirmelidir. İşlem sonrası hekimin önerdiği ağız hijyeni talimatlarına, fırçalama/ara yüz temizliği önerilerine ve kontrol randevularına uymalıdır. Şiddetli ağrı, geçmeyen kanama, şişlik, ateş veya beklenmeyen durumlarda kliniğe başvurulmalıdır.

6. Kullanılabilecek ilaçlar ve istenmeyen Etkileri

İşlem öncesi veya sonrası gerekli görülürse antibiyotik, ağrı kesici, antienflamatuvar, antiseptik gargara, mide koruyucu veya hekimin uygun gördüğü diğer ilaçlar reçete edilebilir. Bu ilaçlara bağlı mide bulantısı, ishal, mide rahatsızlığı, baş dönmesi, uyku hali, cilt döküntüsü, kaşıntı, alerjik reaksiyon ve nadiren anafilaksi gelişebilir. Hasta daha önce ilaç, lokal anestezi, antibiyotik, ağrı kesici veya lateks/materyal alerjisi yaşıyorsa hekime bildirmelidir.

7. Onam Beyanı

Yukarıdaki bilgileri okudum. Restoratif, endodontik ve/veya periodontal işlemlerin amacı, nasıl yapılacağı, alternatifleri, yapılmazsa oluşabilecek sonuçları, riskleri, komplikasyonları, işlem süreleri, işlem öncesi/sonrası dikkat edilecek hususlar, lokal anestezi ve ilaçlara bağlı olası etkiler hakkında hekimim tarafından anlayabileceğim şekilde bilgilendirildim. Bu formdaki bilgiler tarafıma hekimim tarafından sözlü olarak açıklanmıştır. Soru sorma fırsatı buldum, sorularım yanıtlandı. Tedavinin kesin başarı garantisi taşımadığını; işlem sırasında ortaya çıkan klinik gereklilik halinde ilgili diş için doktor görüşüyle kanal tedavisi ya da dolgu/kuafaj işlemi uygulanabileceğini anladım ve kabul ediyorum.

8. İmza Alanı

Hasta el yazısı ile:

(noktalı alana "okudum anladım onaylıyorum" yazınız)

Hasta / Yasal Temsilci - Ad Soyad / İmza / Tarih:

Hekim - Ad Soyad / İmza / Tarih:

Yasal temsilci imzasında yakınlık derecesi ve temsil nedeni hasta dosyasına ayrıca kaydedilir.